

Instituto Vivance — Contexto do Produto, Escopo do MVP e Casos de Uso

Status: documento-base para discovery, produto, design e desenvolvimento

Atualizado em: 1º de setembro de 2026

Escopo: produto clínico e operacional, sem conteúdo comercial

Idioma do MVP recomendado: PT-BR

0. Como usar este documento no Codex

Este documento consolida o conhecimento disponível sobre o Instituto Vivance e propõe um recorte realista para o primeiro MVP operacional.

Ao trabalhar neste projeto, o Codex deve:

1. Tratar os limites clínicos, de privacidade e segurança como requisitos obrigatórios.
2. Diferenciar fatos confirmados, informações fornecidas pelo médico, hipóteses de produto, mocks e decisões pendentes.
3. Inspeccionar o código e os testes antes de assumir que uma funcionalidade ou integração existe.
4. Manter a IA como copiloto e todo conteúdo clínico gerado como rascunho até aprovação explícita do médico.
5. Priorizar o menor fluxo ponta a ponta que entregue valor real ao médico e ao paciente.
6. Evitar transformar todas as telas do protótipo ou todos os usos pessoais de IA do Dr. Guilherme em requisitos do MVP.
7. Não incluir funcionalidades comerciais, marketing, aquisição, pagamentos ou monetização.
8. Não inventar regras clínicas, faixas, alertas, diagnósticos, protocolos ou campos de prontuário. Esses itens dependem de validação do Dr. Guilherme.

Etiquetas de confiança

Sempre que uma nova informação for adicionada ao projeto, classificá-la quando necessário como:

- **VALIDADO**: decisão confirmada pelo responsável de produto e pelo Dr. Guilherme.
- **OBSERVADO NO CÓDIGO**: comportamento comprovado no repositório ou em execução.
- **INFORMADO PELO MÉDICO – A CONFIRMAR**: informação presente nos MDs fornecidos pelo Dr. Guilherme, ainda sem demonstração.
- **HIPÓTESE DE PRODUTO**: recomendação que precisa ser testada.
- **MOCK/PROTÓTIPO**: experiência visual ou dado demonstrativo sem operação real.
- **DECISÃO PENDENTE**: ponto que bloqueia definição segura do comportamento.
- **FORA DO MVP**: item conscientemente adiado.

1. Fontes utilizadas e hierarquia de verdade

Fontes consolidadas

1. **Memória do Projeto — Instituto Vivance**, atualizada em 31 de agosto de 2026.
2. **Como Claude Auxilia Dr. Guilherme Martins**, fornecido pelo próprio médico em agosto de 2026.
3. **Como o ChatGPT me ajuda no meu fluxo de trabalho**, fornecido pelo próprio médico.
4. Protótipo, repositório e estado técnico descritos na memória do projeto.

Os dois documentos fornecidos pelo Dr. Guilherme são fontes primárias de discovery sobre sua rotina, necessidades, ferramentas e modo desejado de trabalhar. Eles **não comprovam**, isoladamente, que integrações, scripts ou automações já estejam em produção.

Hierarquia recomendada

Em caso de divergência, seguir esta ordem:

1. Requisitos legais, clínicos, de segurança e privacidade aprovados.
2. Decisões registradas e datadas, validadas pelo Dr. Guilherme e pelo responsável de produto.
3. Fluxos e requisitos clínicos demonstrados e validados com o médico.
4. Código executável, testes e documentação oficial das integrações, como evidência do estado implementado.
5. Documentos fornecidos pelo médico.
6. Protótipos, mocks e dados fictícios.
7. Recomendações ou sínteses geradas por IA.

O código comprova o que existe, mas não substitui nem pode contrariar um requisito clínico, legal ou de segurança validado.

2. Exclusões explícitas

Este documento não considera:

- Valores, pagamentos ou parcelamentos.
- Contratos, equity, comissões ou participação.
- Precificação, faturamento ou modelos de receita.
- CAC, LTV, funil de vendas ou análise de anúncios.
- Captação e qualificação de leads.
- Marketing, criação de conteúdo ou infoprodutos.
- Comercialização para outras clínicas.
- Promessas de economia, retenção ou retorno financeiro.

As estimativas de tempo presentes nos documentos do médico podem ser usadas apenas como **hipóteses a medir**, nunca como resultados comprovados.

3. Visão do produto

O Instituto Vivance é uma plataforma de **cuidado longitudinal**, inicialmente voltada ao acompanhamento de emagrecimento e saúde do envelhecimento.

O produto deve acompanhar o paciente antes, durante e depois da consulta, centralizando informações que hoje ficam fragmentadas entre mensagens, exames, notas, fotos, documentos, agenda e diferentes sistemas.

Problema central

O médico recebe informações em formatos desestruturados, precisa reconstruir o contexto do paciente, documentar a consulta, transformar decisões em orientações compreensíveis e acompanhar a execução do plano entre consultas.

O paciente, por sua vez, precisa entender o que foi combinado, registrar sua evolução com pouco esforço e saber quais informações serão vistas pelo médico na próxima revisão.

Proposta de valor não comercial

O Vivance deve reduzir a distância entre a informação bruta e uma ação aprovada pelo médico:

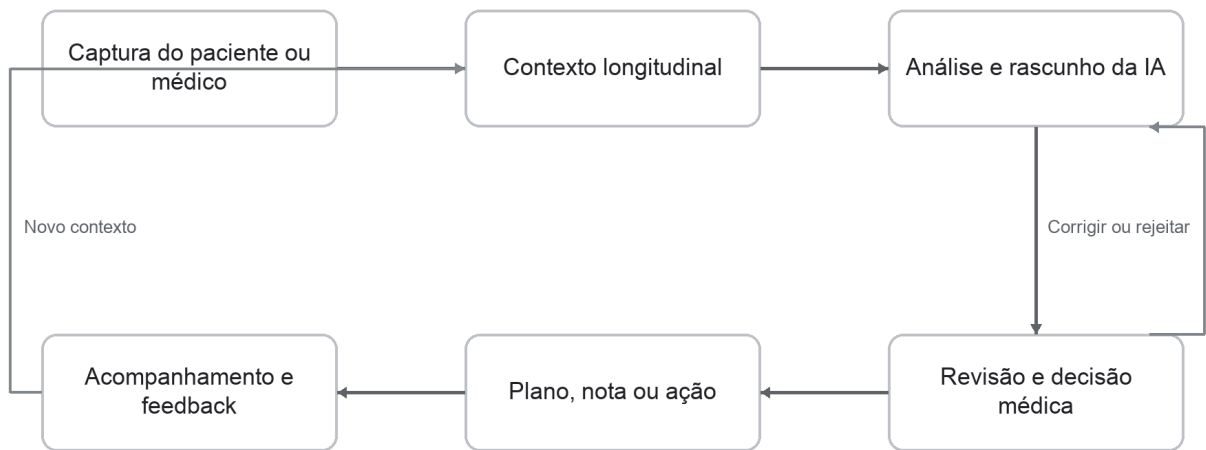


Figura 1 — Ciclo longitudinal de cuidado

O valor não está em uma resposta isolada da IA, mas em preservar contexto, organizar o trabalho, apoiar a decisão humana e fechar o ciclo de acompanhamento.

4. Usuários e estratégia de experiência

Usuários iniciais

Paciente

- Experiência web **mobile-first**.
- Adulto em acompanhamento de emagrecimento e/ou saúde do envelhecimento.
- Registra informações, responde à pré-consulta, consulta o plano e realiza check-ins.
- Acessa somente seus próprios dados e conteúdos publicados pelo médico.

Médico

- Experiência web **desktop-first**.
- Operação inicial centrada no Dr. Guilherme.
- Revisa contexto, atende, registra decisões, aprova rascunhos e acompanha exceções.
- É o responsável final por diagnóstico, conduta, prescrição, comunicação clínica e assinatura.

Administrador técnico

- Papel restrito à configuração e suporte técnico.
- Não deve receber acesso clínico por padrão.
- Qualquer acesso excepcional a dados sensíveis precisa ser justificado, limitado, temporário e auditado.

Usuários futuros, fora do MVP

- Outros médicos.
- Recepção.
- Nutricionistas ou equipe multidisciplinar.
- Gestores de clínica.
- Múltiplas clínicas ou marcas.

5. O que foi aprendido sobre a rotina do Dr. Guilherme

5.1 Método geral de trabalho

O Dr. Guilherme usa IA como uma camada de inteligência operacional entre informação bruta e decisão:

**Entrada bruta → Contexto → Análise → Pesquisa/validação → Refinamento → Decisão
→ Execução → Feedback**

Ele espera poder enviar materiais sem preparar um briefing perfeito, como:

- Texto e perguntas.
- Fotos e prints.
- PDFs e documentos.
- Resultados de exames.
- Conversas.
- Planilhas.
- Links.
- Áudio ou transcrição.
- Ideias incompletas.

O sistema deve organizar o material, recuperar contexto pertinente e separar:

- Fatos e dados originais.

- Informações faltantes.
- Inferências.
- Riscos.
- Alternativas.
- Sugestão operacional ou alternativa para revisão, nunca recomendação terapêutica autônoma.
- Próxima ação possível.

O médico permanece como camada final de julgamento, autorização e decisão.

Essas entradas descrevem o modo geral como o Dr. Guilherme trabalha com IA. Elas não viram automaticamente escopo do produto. No primeiro MVP, as entradas ficam limitadas à pré-consulta por texto, notas do médico e dados explicitamente aprovados para cada fluxo.

5.2 Fluxos clínicos e operacionais informados

Consulta e documentação

Fluxo desejado/informado:

1. Consulta presencial ou on-line.
2. Gravação autorizada ou anotações.
3. Transcrição.
4. Organização em nota clínica estruturada.
5. Revisão e correção pelo médico.
6. Assinatura ou registro final no Feegow.

O documento cita Whisper e um script chamado `agente_vivance.py`. Como o mesmo documento afirma que a automação está “em setup”, esse fluxo deve ser tratado como **PoC ou intenção não comprovada** até demonstração técnica.

Exames e relatórios

Entradas citadas:

- Calorimetria indireta.
- Bioimpedância/BIA.
- Exames laboratoriais.

Saídas desejadas:

- Extração e organização dos dados.
- Relatório explicativo em linguagem acessível.
- PDF visual e/ou DOCX estruturado.

- Mensagem educativa associada.

Qualquer interpretação, plano ou orientação deve permanecer como rascunho até aprovação médica.

Comunicação com pacientes

O médico utiliza o WhatsApp para retorno de exames, explicações e acompanhamento. A IA pode ajudar a redigir textos claros, calorosos e prontos para revisão.

No MVP, `wa.me` ou uma mensagem redigida não devem ser confundidos com integração real. Nenhuma mensagem clínica gerada pela IA pode ser enviada automaticamente.

Contexto longitudinal

O valor aumenta quando o sistema preserva:

- Objetivo do paciente em suas próprias palavras.
- Decisões anteriores.
- Planos e orientações vigentes.
- Check-ins e evolução.
- Conversas e documentos relevantes.
- Pendências.
- Resultado das ações anteriores.

5.3 Ecossistema citado

Sistema ou ferramenta	Papel informado	Estado para o MVP
Feegow	Prontuário eletrônico e registro assinado	Tratar como fonte oficial recomendada até decisão contrária
Visus Vector 2.0	CRM da clínica	Fora do MVP até validação de necessidade e API
PULSE	Contatos e seguimentos	Fora do MVP até validação
Google Drive	Documentos e templates	Não assumir integração automática
WhatsApp / <code>wa.me</code>	Comunicação utilizada pelo médico	Envio manual ou integração futura
Whisper	Transcrição	Extensão após consentimento e avaliação do fornecedor
<code>agente_vivance.py</code>	Integração alegada entre áudio, IA, documentos e Feegow	Não assumir existência ou funcionamento sem inspeção

5.4 Informações profissionais a validar

Existe divergência nos documentos:

- Um MD apresenta CRM-PR 182364 | RQE 73549.
- O cadastro utilizado anteriormente apresenta CRM-SP 182364 | CRM-PR 34614 | RQE 73549.

Não reutilizar nem publicar esses dados sem confirmação oficial do Dr. Guilherme.

6. Papel e limites da inteligência artificial

A IA pode

- Transcrever áudio autorizado.
- Resumir informações fornecidas.
- Organizar respostas por tema.
- Identificar lacunas ou contradições para revisão.
- Gerar rascunhos de notas, relatórios, planos e mensagens.
- Resumir uma linha do tempo.
- Sugerir perguntas que o médico talvez queira confirmar.
- Apoiar pesquisa de evidências para uso exclusivo do médico, com fontes.
- Indicar padrões descritivos sem tratá-los como causalidade.

A IA não pode

- Diagnosticar.
- Prescrever.
- Criar ou alterar dose de medicamento.
- Modificar tratamento.
- Decidir conduta clínica.
- Assinar documentos.
- Publicar plano, nota, relatório ou mensagem clínica sem aprovação.
- Responder clinicamente ao paciente de forma autônoma.
- Declarar que um paciente está seguro ou sem risco.
- Substituir atendimento de urgência ou emergência.
- Estimar com precisão ingredientes, porções, calorias ou nutrientes a partir de fotos.
- Usar dados dos pacientes para treinamento sem autorização específica e juridicamente validada.

Ciclo obrigatório dos artefatos clínicos gerados

Rascunho da IA

- Em revisão médica
- Aprovado pelo médico
- Publicado ou exportado
- Nova versão, se alterado

Regras obrigatórias:

- O conteúdo original nunca pode ser ocultado pela síntese.
- Cada afirmação clínica deve ser rastreável à fonte usada.
- Campos sem evidência devem ficar vazios ou marcados como pendentes.
- Diagnóstico, conduta e medicação só podem aparecer quando inseridos ou confirmados pelo médico.
- O sistema deve registrar modelo/serviço, versão do prompt, fontes, data, autor da revisão e versão aprovada.
- Deve existir um caminho manual quando a IA estiver indisponível.

Recusa do uso de IA no cuidado

Quando o paciente exercer a recusa informada:

- O status deve ser registrado e ficar visível ao médico.
- Pré-consulta continua disponível, mas sem síntese de IA.
- Dossiê continua acessível pelas fontes originais, sem resumo de IA.
- Nota e plano são elaborados manualmente.
- Áudio não é enviado a serviço de transcrição por IA.
- Nenhum dado daquele paciente é enviado ao provedor para os casos recusados.
- A recusa não impede acesso, consulta ou continuidade do cuidado.
- Eventual mudança de escolha deve ser versionada e valer apenas para novos processamentos.

7. Estado atual conhecido

Protótipo construído

Paciente

- Hoje.
- Plano.
- Diário.

- Evolução.
- Mensagens.
- Consultas.
- Check-in diário.
- Pré-consulta por voz ou texto.
- Registro demonstrativo de refeições.
- Indicadores de peso, adesão, sono e passos.
- Histórico e relatórios demonstrativos.

Médico

- Visão geral.
- Agenda.
- Pacientes.
- Mensagens.
- Relatórios.
- Ambiente de consulta.
- Caixa de atenção por exceção.
- Dossiê longitudinal.
- Notas estruturadas.
- Rascunhos de relatório e plano.

Os pacientes, consultas, métricas, alertas e documentos atuais são fictícios.

Estado técnico registrado em 31 de agosto de 2026

- React 19.
- Next.js 16.
- TypeScript.
- Tailwind CSS.
- Menção adicional a Vinext/Vite.
- Preparação para Sites/Cloudflare.
- Branch registrada: `main`.
- Commit registrado: `8fe9cf59b055615ea736cdbf734baf86a9b3ec70`.

Antes de modificar o projeto, o Codex deve conferir o repositório real. A combinação Next.js e Vinext/Vite, o commit, a hospedagem e a estrutura podem ter mudado.

Na memória datada de 31 de agosto, os principais componentes eram descritos como doctor.tsx e patient.tsx, e os PDFs mockados ficavam em output/pdf/. Esses caminhos são referências históricas e precisam ser confirmados no repositório.

A URL publicada ainda utilizava a marca antiga Lume Saúde e respondeu HTTP 401 em verificação anônima. Não tratá-la como ambiente de produção nem apresentá-la externamente sem revalidação.

Ainda não comprovado como operacional

- Autenticação real.
- Banco de dados persistente.
- Upload real e seguro.
- Separação entre clínicas.
- Integração com Feegow.
- Integração com WhatsApp.
- Gravação e transcrição em produção.
- Google Meet ou vídeo real.
- Prescrição digital.
- Integração com prontuário.
- Apple HealthKit, Health Connect ou relógios.
- Base médica conectada.
- Operação 24 horas.
- Certificação como prontuário ou dispositivo médico.

8. Hipótese recomendada para o MVP

O produto possui duas hipóteses de valor relacionadas, mas não deve tentar validá-las simultaneamente no primeiro piloto.

MVP-1 — Eficiência da consulta

Primeiro, validar se uma plataforma supervisionada pelo médico consegue:

1. Organizar o contexto antes da consulta.
2. Reduzir o trabalho manual de preparação e documentação.
3. Transformar decisões médicas em uma nota rastreável e um plano claro.
4. Manter o Feegow como prontuário oficial.

Essa é a primeira fatia recomendada porque os documentos do Dr. Guilherme descrevem dores concretas de preparação, transcrição e documentação.

MVP-2 — Acompanhamento longitudinal

Depois que o MVP-1 estiver estável, validar se o Vivance consegue:

1. Acompanhar a execução do plano entre consultas.
2. Coletar check-ins simples com baixo atrito.
3. Destacar pendências operacionais explicáveis.
4. Permitir que o médico registre uma ação e feche o ciclo.

Recorte operacional recomendado

- Uma clínica: Instituto Vivance.
- Um médico: Dr. Guilherme.
- Poucos pacientes em piloto controlado.
- Adultos, salvo decisão clínica em contrário.
- Feegow como fonte oficial do prontuário e assinatura.
- Vivance como camada de preparação, rascunhos e contexto; acompanhamento longitudinal é adicionado no MVP-2.
- Transferência manual segura ao Feegow antes de integração automática.
- Regras de atenção inicialmente operacionais, sem triagem ou score clínico.

Jornadas divididas em duas entregas

MVP-1: Jornada A — Preparação da consulta

Convite → Ciência/aceites aplicáveis → Objetivo → Pré-consulta
→ Síntese com fontes → Revisão médica

MVP-1: Jornada B — Consulta, nota e plano

Contexto → Notas ou transcrição existente → Rascunho
→ Edição/aprovação médica → Exportação ao Feegow
→ Plano aprovado publicado ao paciente

MVP-2: Jornada C — Acompanhamento por exceção

Plano ativo → Check-in curto → Regra transparente
→ Item de atenção → Revisão e ação médica → Feedback

9. Escopo recomendado

9.1 MVP-1 — obrigatório para o primeiro piloto

Módulo	Incluído no MVP-1
Identidade e acesso	Login seguro, MFA do médico, convite individual, recuperação de acesso e sessões protegidas
Vínculo	Médico cria, verifica e pode revogar a relação com o paciente
Privacidade e aceites	Ciência do aviso, aceite de termos e consentimento granular somente quando aplicável
Cadastro mínimo	Identificação, objetivo nas palavras do paciente e referência opcional ao Feegow
Pré-consulta	Questionário por texto, salvamento de progresso, revisão e envio
Síntese assistida	Resumo com fontes, lacunas e pontos a confirmar
Painel médico	Pacientes, pré-consultas e rascunhos pendentes
Dossiê	Objetivo, pré-consultas, planos, notas e linha do tempo mínima
Workspace clínico	Notas manuais ou transcrição já existente, organização pela IA e revisão
Nota clínica	Rascunho versionado, aprovação e cópia/exportação segura ao Feegow
Plano de cuidado	Rascunho, aprovação, publicação e histórico de versões
Privacidade operacional	Canal e processo auditável para revogação, acesso, correção e exclusão conforme política
Auditoria	Registro de acessos e ações sensíveis

9.2 MVP-2 — acompanhamento longitudinal

Adicionar somente após o MVP-1 estar estável:

Módulo	Incluído no MVP-2
Check-in	Formulário curto, histórico e identificação como autorrelato
Plano acionável	Paciente visualiza as ações aprovadas; confirmação de execução é opcional e deve ser definida
Evolução mínima	Histórico simples, sem inferir dados ausentes
Atenção operacional	Pré-consulta, check-in, nota, plano ou revisão pendentes
Ação médica	Registro de revisão, contato externo, relevância e encerramento

Regras baseadas em sintomas, piora, risco ou urgência não fazem parte desta entrega sem avaliação de risco, validação clínica e cobertura operacional.

9.3 P1 — extensões após o núcleo estável

Escolher **uma extensão de cada vez**, com base no maior gargalo observado:

1. **Upload de documentos:** PDF/imagem, armazenamento privado, metadados e acesso controlado.
2. **Áudio e transcrição nativa:** consentimento específico, upload/gravação, transcrição, marcação de baixa confiança e política de retenção.
3. **Relatório assistido de um tipo de exame:** começar por calorimetria ou bioimpedância, usando um único template aprovado.
4. **Integração Feegow:** somente após comprovação de API, autenticação, permissões, campos, duplicidade e logs.
5. **Mensagens internas:** canal assíncrono com expectativa de resposta e sem resposta autônoma da IA.
6. **WhatsApp:** lembretes e textos aprovados, sem envio clínico automático.
7. **Evolução visual:** gráficos simples e reproduzíveis de peso, adesão, sono e bem-estar.
8. **Refeições:** foto e contexto subjetivo, sem estimativas nutricionais precisas.
9. **Relatórios periódicos:** narrativa gerada e publicada somente após revisão médica.

9.4 Fora do MVP

- Substituir o Feegow por um prontuário próprio.
- Diagnóstico, prescrição ou alteração de tratamento pela IA.
- Chatbot clínico autônomo.
- Monitoramento 24 horas ou promessa de urgência.
- Teleconsulta nativa com vídeo.
- Prescrição digital e emissão de receitas.
- Agenda bidirecional completa.
- Integrações simultâneas com Feegow, PULSE, Visus, Drive e WhatsApp.
- Multi-clínica operacional, white label ou equipes complexas.
- Protocolos totalmente configuráveis.
- HealthKit, Health Connect, smartwatches ou balanças conectadas.
- Análise precisa de calorias ou nutrientes por foto.
- Motor preditivo de risco clínico.
- Pesquisa clínica aplicando conduta automaticamente.
- Internacionalização.
- Funcionalidades comerciais.

10. Fronteira recomendada entre Vivance e Feegow

Esta é uma recomendação de MVP e deve ser confirmada com o Dr. Guilherme.

Entidade ou ação	Fonte recomendada	Regra no Vivance
Cadastro clínico oficial	Feegow	Manter somente os campos mínimos e a referência externa
Prontuário e nota assinada	Feegow	Manter fontes, rascunho, versão aprovada para exportação e evidência da transferência conforme retenção definida
Diagnóstico oficial	Feegow	Não criar diagnóstico autônomo
Prescrição e receita	Feegow ou sistema autorizado	Fora do Vivance no MVP
Agenda oficial	Feegow	No máximo, referência manual no MVP
Pré-consulta	Vivance	Fonte original; médico decide o que é clinicamente relevante para registrar no Feegow
Resumo preparatório	Vivance	Artefato derivado e rastreável
Plano exibido ao paciente	Vivance	Decisões clínicas relevantes também precisam ser registradas no Feegow conforme processo aprovado
Check-ins	Vivance	Autorrelatos; informações clinicamente relevantes podem exigir registro no Feegow
Fila e ações operacionais	Vivance	A fila é operacional; observação, contato ou ação clínica relevante deve ser registrada e reconciliada no Feegow
Transferência automática	Nenhuma no MVP-1	Só após homologação

Antes do piloto, definir para cada entidade:

- Fonte oficial.
- Versão que deve ser levada ao Feegow.
- Prazo de retenção no Vivance.
- Identificador externo.
- Responsável pela transferência.
- Comportamento quando a transferência falhar.
- Processo de reconciliação quando os sistemas divergirem.

Estados mínimos da transferência:

- Pendente.
- Exportado, ainda não verificado.
- Confirmado manualmente pelo médico.

- Sincronizado por integração homologada.
- Falhou.

Uma confirmação manual é evidência operacional; não significa sincronização. Se houver divergência em conteúdo clínico oficial, o Feegow prevalece até que uma nova versão seja revisada e reconciliada.

11. Papéis e permissões mínimas

Ação	Paciente	Médico	Admin técnico
Ver próprios dados	Sim	—	Não por padrão
Ver paciente vinculado	Não	Sim	Não por padrão
Responder pré-consulta/check-in	Sim	Consultar	Não
Ver conteúdo original do paciente	Próprio	Sim	Não por padrão
Criar nota clínica	Não	Sim	Não
Gerar rascunho por IA	Apenas fluxos permitidos	Sim	Não
Aprovar conteúdo clínico	Não	Sim	Não
Publicar plano ou relatório	Não	Sim	Não
Alterar regras clínicas	Não	Sim, após validação	Não
Gerenciar consentimentos próprios	Sim	Consultar quando necessário	Operação restrita
Consultar auditoria clínica	Não	Conforme necessidade	Somente escopo autorizado

Autorização deve ser aplicada no backend. Ocultar um botão na interface não é controle de acesso suficiente.

O responsável por privacidade é um papel organizacional separado do administrador técnico. No MVP, solicitações podem ser executadas por processo externo aprovado, desde que o Vivance registre a solicitação, o status e a evidência da conclusão quando aplicável.

12. Requisitos funcionais transversais

Identidade e vínculo

- Convites individuais, expiráveis e de uso único.
- Identificadores não previsíveis.

- Paciente acessa apenas seu próprio perfil.
- Médico acessa somente pacientes vinculados.
- Sessões expiráveis e revogáveis.
- Recuperação de conta segura.

Privacidade, avisos e consentimentos

- Registrar separadamente a ciência do aviso de privacidade, o aceite de termos e o consentimento quando ele for a base aplicável.
- Definir finalidade e base legal antes de criar a interface.
- Não chamar um tratamento de dados de “obrigatório” apenas porque o produto o deseja.
- Consentimentos opcionais devem ser granulares.
- Gravação/transcrição exige autorização específica.
- Recusa do uso de IA ligado ao cuidado deve oferecer um fluxo integralmente manual equivalente.
- Recusa não pode ser convertida silenciosamente em aceite.
- Revogação deve interromper novos processamentos abrangidos, respeitando retenções legais.

Conteúdo clínico e IA

- Todo artefato gerado deve ter fonte, status e versão.
- Rascunhos nunca ficam visíveis ao paciente.
- Apenas o médico publica ou aprova.
- O sistema deve mostrar a diferença entre dado do paciente, nota do médico, inferência da IA e conteúdo aprovado.
- Nenhum envio clínico automático.
- Falha de IA não pode impedir o fluxo manual.

Linha do tempo

- Cada evento registra data, autor, origem e tipo.
- No MVP-1, o médico filtra por pré-consulta, consulta, nota e plano.
- Check-in e atenção entram no MVP-2; documentos entram no P1.
- Paciente vê apenas eventos destinados a ele.
- Ausência de dados deve ser exibida como ausência, nunca preenchida por estimativa.

Atenção por exceção

- No MVP-2, começar apenas com regras operacionais transparentes.
- Cada item mostra a regra, fonte, data e resposta que o originou.
- Estados mínimos: novo, em revisão, ação registrada e encerrado.
- O médico registra se o item foi útil ou falso positivo.
- A fila não representa vigilância em tempo real.
- Regras baseadas em sintomas, piora ou risco exigem avaliação de risco, validação clínica e processo operacional próprio.

Documentos (P1)

- Preservar o arquivo original.
- Validar formato, tamanho e integridade.
- Registrar tipo, data, origem, paciente e consulta relacionada.
- Controlar upload, visualização e download por permissão.
- Não tratar documento enviado pelo paciente como validado clinicamente.

13. Casos de uso principais do MVP

Convenções

- **MVP-1:** primeira validação, focada em preparação e documentação da consulta.
- **MVP-2:** segunda validação, focada no acompanhamento longitudinal.
- **P1:** extensão posterior, adicionada somente após estabilidade do núcleo.
- **Ator principal:** pessoa responsável por iniciar ou concluir o objetivo.
- **Copiloto de IA:** componente que produz transcrição, síntese ou rascunho; nunca aprova.

Resumo

ID	Caso de uso	Prioridade	Ator principal
UC-00	Autenticar médico, vincular paciente e controlar convite	MVP-1	Médico
UC-01	Ativar conta e registrar ciência/aceites	MVP-1	Paciente
UC-02	Completar cadastro mínimo e objetivo	MVP-1	Paciente
UC-03	Realizar pré-consulta	MVP-1	Paciente

ID	Caso de uso	Prioridade	Ator principal
UC-04	Revisar painel e preparar a consulta	MVP-1	Médico
UC-05	Consultar o dossiê longitudinal	MVP-1	Médico
UC-06	Criar e aprovar uma nota clínica	MVP-1	Médico
UC-07	Criar e publicar o plano de cuidado	MVP-1	Médico
UC-08	Registrar check-in	MVP-2	Paciente
UC-09	Revisar e resolver um item de atenção	MVP-2	Médico
UC-10A	Visualizar plano aprovado	MVP-1	Paciente
UC-10B	Visualizar histórico e evolução	MVP-2	Paciente
UC-11	Gerenciar privacidade e direitos do titular	Processo obrigatório; autosserviço opcional	Paciente
UC-12	Gerar relatório explicativo de exame	P1	Médico
UC-13	Transcrever áudio de consulta	P1	Médico
UC-14	Trocar mensagens dentro do Vivance	P1	Paciente/ Médico

UC-00 — Autenticar médico, vincular paciente e controlar convite

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** médico e sistema.
- **Objetivo:** garantir que a pré-consulta seja enviada à pessoa correta e que o vínculo possa ser encerrado.
- **Pré-condições:** perfil do Dr. Guilherme verificado; MFA configurado; política de identidade definida.
- **Gatilho:** médico acessa o painel ou inicia a inclusão de um paciente.

Fluxo principal

1. O médico autentica com MFA.
2. Busca o paciente por identificadores mínimos.
3. O sistema verifica possível duplicidade e referências externas.
4. O médico confirma a identidade e cria o vínculo.
5. Define manualmente o período ou atendimento associado à pré-consulta.
6. O sistema gera convite individual, expirável e de uso único.
7. O médico acompanha o status do convite.
8. Quando necessário, revoga o convite ou o acesso futuro.

Exceções

- Possível duplicidade.
- Paciente já vinculado.
- Contato incorreto.
- Convite expirado.
- Conta do médico sem MFA ou sessão expirada.

Pós-condições

- Vínculo auditável e convite associado ao paciente correto.

Participação da IA

Nenhuma. Identidade, vínculo, convite e revogação não dependem de IA.

Critérios de aceitação

- MFA é obrigatório para o médico.
- Duplicidades exigem confirmação antes da criação.
- Convite não expõe dados clínicos.
- Revogação invalida convites pendentes e impede novos acessos conforme política.
- Vínculo, revogação e envio ficam auditados.

UC-01 — Ativar conta e registrar ciência/aceites

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** paciente, médico e sistema.
- **Objetivo:** permitir acesso seguro e registrar ciência, termos e consentimentos somente quando aplicáveis.
- **Pré-condições:** paciente convidado; textos legais, finalidades e bases legais definidos.
- **Gatilho:** paciente abre o convite individual.

Fluxo principal

1. O paciente abre um link individual, expirável e de uso único.
2. Confirma sua identidade e cria suas credenciais.
3. Lê o aviso de privacidade e os termos aplicáveis.
4. Registra ciência do aviso e aceite dos termos.
5. Manifesta consentimento separado apenas para finalidades em que ele seja a base aplicável, como gravação opcional.

6. É informado sobre o uso de IA ligado ao cuidado e pode recusá-lo.
7. O sistema registra documento, versão, finalidade, base aplicável, data, hora e usuário.
8. A conta é vinculada ao Dr. Guilherme e ao Instituto Vivance.
9. O paciente é direcionado ao cadastro mínimo.

Exceções

- Convite expirado, inválido ou já utilizado.
- E-mail ou telefone vinculado a outra conta.
- Recusa de gravação, de uso de IA no cuidado ou de outro processamento baseado em consentimento.
- Sessão expirada.

Pós-condições

- Conta ativa e vinculada.
- Registros de ciência, aceite e consentimentos aplicáveis auditáveis.
- Nenhum dado clínico liberado antes da autenticação e dos aceites necessários.

Participação da IA

Nenhuma decisão. A ativação e o consentimento não dependem de IA.

CrITÉRIOS de aceitação

- Um convite válido ativa apenas uma conta.
- O paciente não acessa dados de outro paciente alterando URL ou identificador.
- Ciência, termos e consentimentos são armazenados separadamente.
- Cada registro possui versão, finalidade, data e hora.
- Consentimentos podem ser recusados sem serem registrados como aceitos.
- A recusa do uso de IA no cuidado ativa um fluxo integralmente manual, sem impedir o atendimento.
- A revogação posterior pode ser relacionada ao aceite original.

UC-02 — Completar cadastro mínimo e objetivo

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** paciente e sistema.
- **Objetivo:** coletar somente os dados necessários para iniciar o acompanhamento.
- **Pré-condições:** conta ativa.
- **Gatilho:** primeiro acesso ou perfil incompleto.

Fluxo principal

1. O paciente informa nome, data de nascimento e contato.
2. O sistema apresenta os dados já conhecidos para confirmação.
3. O paciente descreve seu objetivo principal em texto livre.
4. O sistema salva o texto original integralmente.
5. A IA pode produzir uma versão curta do objetivo, identificada como síntese.
6. O paciente revisa e conclui.

Exceções

- Campo obrigatório ausente.
- Possível duplicidade de paciente.
- Informação conflitante com um vínculo existente.

Pós-condições

- Perfil mínimo criado.
- Objetivo original e eventual síntese preservados separadamente.

Participação da IA

Pode resumir o objetivo sem substituir o texto escrito pelo paciente.

Critérios de aceitação

- O texto original nunca é sobrescrito pela síntese.
- O sistema diferencia dado fornecido pelo paciente e texto gerado por IA.
- Campos já mantidos oficialmente no Feegow não são duplicados sem necessidade.
- O identificador externo do Feegow é opcional e validado antes de ser salvo.

UC-03 — Realizar pré-consulta

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** paciente, médico, sistema e copiloto de IA.
- **Objetivo:** coletar e organizar informações antes da consulta.
- **Pré-condições:** paciente autenticado; questionário aprovado pelo Dr. Guilherme.
- **Gatilho:** paciente inicia uma pré-consulta vinculada a um atendimento ou período de revisão.

Fluxo principal

1. O sistema explica a finalidade e informa que não é um canal de emergência.
2. Apresenta uma pergunta por vez.
3. O paciente responde por texto.
4. O progresso é salvo automaticamente.
5. O paciente revisa todas as respostas.
6. Envia a versão final.
7. A IA organiza as respostas, identifica lacunas e gera uma síntese.
8. O médico recebe respostas originais e síntese, com vínculo entre ambas.

Exceções

- Preenchimento interrompido.
- Conexão perdida.
- Resposta incompleta.
- Falha da IA.
- Paciente recusou IA: respostas originais seguem ao médico sem síntese.

Pós-condições

- Pré-consulta com status enviada.
- Conteúdo original disponível ao médico.
- Síntese marcada como rascunho.

Participação da IA

Resumir, organizar e indicar pontos a confirmar. Não diagnosticar, priorizar clinicamente de forma autônoma ou orientar tratamento.

Crítérios de aceitação

- O paciente retoma um preenchimento interrompido.
- Respostas incompletas não são apresentadas como versão final.
- A submissão gera confirmação visível.
- Cada item da síntese permite localizar a resposta de origem.
- A falha da IA não impede o envio e a leitura das respostas originais.
- A orientação de emergência aparece de forma permanente e não depende de um detector de texto.
- Voz fica fora do MVP-1; texto é o caminho obrigatório e funcional.

UC-04 — Revisar painel e preparar a consulta

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** médico, sistema e copiloto de IA.
- **Objetivo:** apresentar rapidamente as pendências e o contexto necessário para o atendimento.
- **Pré-condições:** médico autenticado; pacientes vinculados.
- **Gatilho:** médico abre a visão geral.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta pacientes com pré-consulta pronta ou pendente e rascunhos aguardando revisão.
2. Cada item mostra motivo, data e status.
3. O médico busca ou seleciona um paciente.
4. O dossiê é aberto diretamente.
5. A IA mostra um resumo recente com fontes.
6. O médico valida os pontos que deseja abordar.

Exceções

- Paciente sem histórico.
- Pré-consulta não concluída.
- Resumo indisponível.
- Informação conflitante.

Pós-condições

- Médico preparado com acesso às fontes, sem depender do resumo.

Participação da IA

Sintetizar fatos registrados e apontar lacunas. Não determinar diagnóstico ou urgência.

Critérios de aceitação

- Cada pendência exibe motivo e data.
- Clicar no paciente abre seu dossiê.
- Ausência de informação é mostrada explicitamente.
- Conteúdo gerado por IA é visualmente distinto.
- Notas internas do médico não ficam visíveis ao paciente.

- Uma agenda completa do Feegow não é requisito do MVP-1.

UC-05 — Consultar o dossiê longitudinal

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** médico e sistema.
- **Objetivo:** reunir o histórico relevante sem misturar origens e níveis de acesso.
- **Pré-condições:** paciente vinculado e pelo menos um registro existente.
- **Gatilho:** médico abre o paciente.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta identificação e objetivo principal.
2. Exibe uma linha do tempo cronológica.
3. No MVP-1, o médico filtra por pré-consulta, consulta, nota e plano.
4. Abre o conteúdo original de cada item.
5. Consulta uma síntese longitudinal opcional.
6. Registra uma observação ou abre o workspace clínico.

Exceções

- Histórico insuficiente.
- Registro corrigido ou substituído.
- Síntese falha ou desatualizada.

Pós-condições

- Contexto acessado e evento de visualização sensível auditado conforme política.

Participação da IA

Gerar síntese descritiva com links às fontes; correlações devem ser apresentadas como hipótese, nunca causalidade.

Critérios de aceitação

- Cada evento mostra data, autor e origem.
- O médico consegue abrir as fontes usadas pela síntese.
- Ausência de dados não é preenchida pela IA.
- O paciente não acessa notas internas, rascunhos ou itens restritos.
- Correções preservam histórico e autoria.

UC-06 — Criar e aprovar uma nota clínica

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** médico, sistema e copiloto de IA.
- **Objetivo:** reduzir o trabalho de documentação mantendo autoria e responsabilidade médicas.
- **Pré-condições:** paciente selecionado; consulta ou encontro registrado.
- **Gatilho:** médico abre o workspace clínico.

Fluxo principal

1. O médico vê a pré-consulta e o resumo longitudinal.
2. Registra notas manualmente ou cola uma transcrição obtida por meio autorizado.
3. Solicita a organização do conteúdo.
4. A IA gera um rascunho estruturado.
5. O médico compara o rascunho com as fontes.
6. Edita, complementa, rejeita ou gera nova versão.
7. Aprova explicitamente a versão final.
8. Confere nome completo, data de nascimento e identificador do Feegow quando disponível.
9. Confirma explicitamente o paciente de destino.
10. Copia ou exporta a nota aprovada para o Feegow.
11. Registra na nota destinada ao Feegow que houve apoio de IA, conforme processo aprovado.
12. Confirma que realizou a transferência.

Exceções

- IA indisponível.
- Paciente recusou IA: nota é integralmente manual.
- Fonte incompleta ou contraditória.
- Conteúdo sem rastreabilidade.
- Exportação falha.
- Integração com Feegow não homologada.

Pós-condições

- Nota aprovada, versionada e auditável.
- Registro da transferência manual, sem alegação de sincronização automática.

Participação da IA

Estruturar somente informações presentes nas fontes. Não inventar diagnóstico, medicamento, dose, exame ou conduta.

Critérios de aceitação

- O fluxo manual funciona sem IA.
- O rascunho nunca é exibido como nota assinada.
- Campo sem evidência permanece vazio ou pendente.
- Diagnóstico e conduta aparecem apenas se inseridos ou confirmados pelo médico.
- A aprovação registra médico, data, hora e versão.
- O uso de IA é informado ao paciente e registrado no prontuário conforme a Resolução CFM nº 2.454/2026.
- A exportação exige confirmação por pelo menos dois identificadores do paciente e pelo ID Feegow quando disponível.
- Divergência de identidade bloqueia a exportação.
- Alteração posterior gera nova versão ou adendo.
- A interface não informa “sincronizado” sem confirmação técnica.
- A versão aprovada não é sobrescrita silenciosamente.

UC-07 — Criar e publicar o plano de cuidado

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** médico, paciente, sistema e copiloto de IA.
- **Objetivo:** transformar decisões médicas em ações claras para o paciente.
- **Pré-condições:** paciente vinculado; decisões registradas pelo médico.
- **Gatilho:** médico inicia ou atualiza um plano.

Fluxo principal

1. O médico inicia o plano manualmente ou a partir da nota aprovada.
2. A IA organiza as orientações em rascunho.
3. O médico define objetivo, ações, frequência/prazo e data de revisão.
4. Revisa e aprova.
5. Publica o plano.
6. O paciente recebe notificação genérica, sem conteúdo clínico sensível.
7. O plano aparece na área Hoje/Plano.

Exceções

- Plano incompleto.
- Orientações conflitantes.
- Rascunho abandonado.
- Plano anterior ativo.
- IA indisponível.
- Paciente recusou IA: plano é elaborado manualmente.

Pós-condições

- Uma única versão ativa e aprovada visível ao paciente.
- Histórico preservado.

Participação da IA

Organizar decisões já registradas. Não criar prescrição, dose ou mudança terapêutica.

Critérios de aceitação

- Rascunhos não são visíveis ao paciente.
- Apenas o médico publica ou substitui.
- A publicação registra autor, data, hora e versão.
- Substituição preserva o plano anterior e identifica o vigente.
- Sugestão da IA não altera um plano publicado.
- Prescrição e receita digital ficam fora deste fluxo.

UC-08 — Registrar check-in

- **Prioridade:** MVP-2.
- **Atores:** paciente, médico e sistema.
- **Objetivo:** captar sinais simples entre consultas com baixo esforço.
- **Pré-condições:** plano ativo ou protocolo de check-in aprovado.
- **Gatilho:** paciente abre o check-in previsto.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta formulário curto.
2. O paciente responde aos campos configurados.
3. O sistema valida formato e valores impossíveis.
4. O paciente revisa e envia.

5. Recebe confirmação.
6. O registro aparece na linha do tempo e no painel médico.
7. A ausência do check-in pode gerar uma pendência operacional.

Conjunto inicial sugerido, sujeito à validação

- Peso informado, quando aplicável.
- Adesão percebida.
- Qualidade do sono.
- Bem-estar geral.
- Dificuldade principal.
- Campo livre para algo que deseja discutir.

Exceções

- Valor inválido.
- Check-in duplicado.
- Conexão perdida.
- Campo opcional não respondido.

Pós-condições

- Check-in datado, com origem identificada como autorrelato.

Participação da IA

Pode resumir tendências posteriormente. Não interpretar um sinal isolado como diagnóstico.

Critérios de aceitação

- Formulário distingue campos obrigatórios e opcionais.
- Falha de conexão não apaga o preenchimento.
- O médico acessa cada resposta original.
- Dado declarado não é apresentado como medição clínica confirmada.
- Pendências operacionais exibem exatamente o evento e o critério usados.
- A interface comunica que o sistema não é monitorado 24 horas.
- Regras baseadas no conteúdo clínico das respostas não são ativadas sem avaliação de risco e validação específica.

UC-09 — Revisar e resolver um item de atenção

- **Prioridade:** MVP-2.

- **Atores:** médico e sistema.
- **Objetivo:** organizar o trabalho por exceção sem criar uma falsa triagem clínica.
- **Pré-condições:** regras aprovadas e dados suficientes.
- **Gatilho:** uma regra explícita é atendida ou o médico abre a fila.

Fluxo principal

1. O sistema cria o item mostrando regra, fonte e data.
2. O médico abre o contexto.
3. Decide revisar, adiar, registrar contato externo ou encerrar.
4. Registra uma observação e a ação tomada.
5. Informa se o item foi relevante ou falso positivo.
6. O sistema atualiza o status e preserva o evento original.

Exceções

- Item duplicado.
- Regra desatualizada.
- Dado corrigido.
- Paciente sem canal de contato.

Pós-condições

- Item tratado, adiado ou mantido com justificativa.
- Feedback disponível para avaliar a regra.

Participação da IA

Pode resumir o contexto. No MVP-2, a fila depende de regra operacional explícita, não de score opaco ou interpretação de sintomas.

Critérios de aceitação

- Todo item mostra motivo, fonte e data.
- Duplicidades do mesmo evento são consolidadas.
- Encerrar não apaga o evento que originou o item.
- O médico registra ação e relevância.
- O sistema não envia mensagem clínica automaticamente.
- A interface não usa linguagem de diagnóstico, emergência ou monitoramento contínuo.

UC-10A — Visualizar plano aprovado

- **Prioridade:** MVP-1.
- **Atores:** paciente e sistema.
- **Objetivo:** permitir que o paciente entenda o plano vigente aprovado pelo médico.
- **Pré-condições:** paciente autenticado; conteúdo publicado.
- **Gatilho:** paciente abre Hoje ou Plano.

Fluxo principal

1. O sistema mostra o plano ativo e suas ações.
2. O paciente consulta orientações publicadas.

Exceções

- Nenhum plano publicado.
- Plano encerrado ou substituído.

Pós-condições

- Paciente informado sem acesso a conteúdo interno.

Participação da IA

Nenhuma. O paciente vê somente a versão aprovada pelo médico.

Critérios de aceitação

- Apenas conteúdo aprovado é exibido.
- O sistema identifica claramente o plano vigente.
- Rascunhos e notas internas não aparecem.
- Um plano substituído não permanece identificado como ativo.
- Notificações externas não contêm conteúdo sensível.

UC-10B — Visualizar histórico e evolução

- **Prioridade:** MVP-2.
- **Atores:** paciente e sistema.
- **Objetivo:** permitir que o paciente acompanhe check-ins e evolução ao longo do tempo.
- **Pré-condições:** paciente autenticado; dados do MVP-2 existentes.
- **Gatilho:** paciente abre Evolução.

Fluxo principal

1. O sistema apresenta o histórico de check-ins e planos anteriores permitidos.
2. Mostra indicadores simples baseados nos registros existentes.
3. O paciente escolhe um período.

Exceções

- Dados insuficientes.
- Período sem registros.

Pós-condições

- Paciente vê seu histórico sem inferência de dados ausentes.

Participação da IA

Nenhuma obrigatoria. Narrativas de evolução ficam para P1 e exigem aprovação médica.

Crerios de aceitaçaõ

- Ausência de dados não gera estimativa.
- Cálculos são reproduzíveis a partir dos registros originais.
- Notificações externas não contêm conteúdo sensível.

UC-11 — Gerenciar privacidade e direitos do titular

- **Prioridade:** processo obrigatório antes do piloto; autosserviço no produto é opcional.
- **Atores:** paciente, responsável organizacional por privacidade e sistema.
- **Objetivo:** permitir transparência, revogação e atendimento auditável aos direitos do titular.
- **Pré-condições:** políticas e responsabilidades definidas.
- **Gatilho:** paciente consulta aceites ou inicia uma solicitação.

Fluxo principal

1. O paciente consulta documentos e registros vigentes no produto ou pelo canal oficial.
2. Solicita acesso, correção, revogação, portabilidade quando aplicável ou exclusão pelo produto ou canal externo aprovado.
3. O responsável confirma a identidade e registra a solicitação.
4. O responsável avalia obrigações de retenção.
5. Executa a ação aplicável ou registra justificativa.
6. O paciente recebe o resultado.

7. Todo o processo é auditado.

Exceções

- Identidade não confirmada.
- Pedido incompatível com obrigação legal de guarda.
- Dados compartilhados com operador ou suboperador.
- Pedido duplicado.

Pós-condições

- Solicitação atendida ou justificada.
- Novos processamentos opcionais interrompidos após revogação aplicável.

Participação da IA

Nenhuma decisão. IA não determina direito, retenção ou exclusão.

Critérios de aceitação

- Histórico de versões e aceites visível.
- Revogar áudio não impede nota manual.
- O sistema não promete exclusão de registros sujeitos a retenção obrigatória.
- Solicitação registra tipo, status, responsável e datas.
- Processo contempla dados enviados a fornecedores.
- O primeiro piloto pode executar a solicitação fora do produto, desde que exista canal, responsabilidade e evidência auditável.

Casos resumidos de P1

Os casos a seguir registram intenção e limites principais. Antes de entrarem em desenvolvimento, precisam ser detalhados no mesmo nível dos casos do MVP-1.

UC-12 — Gerar relatório explicativo de exame

- **Prioridade:** P1.
- **Atores:** médico, paciente, sistema e copiloto de IA.
- **Objetivo:** reduzir o esforço para explicar um tipo de exame homologado.
- **Pré-condições:** um tipo de documento e um template aprovados pelo médico.
- **Gatilho:** médico envia um PDF ou imagem para o paciente correto.

Fluxo principal

1. O sistema valida e preserva o arquivo original.
2. A IA extrai dados suportados e aponta a região de origem.
3. Valores de baixa confiança são marcados.
4. O médico valida a extração.
5. A IA gera um relatório explicativo em rascunho.
6. O médico corrige e aprova.
7. O relatório aprovado é publicado.

Critérios de aceitação essenciais

- Começar com somente calorimetria ou bioimpedância.
- Nenhuma conclusão clínica é publicada sem aprovação.
- Documento original e valores extraídos permanecem vinculados.
- Dado ausente não é inventado.
- Documento não suportado segue para tratamento manual.

UC-13 — Transcrever áudio de consulta

- **Prioridade:** P1.
- **Atores:** médico, paciente, sistema e serviço de transcrição.
- **Objetivo:** transformar áudio autorizado em uma fonte revisável para a nota.
- **Pré-condições:** consentimento específico; fornecedor aprovado; retenção definida.
- **Gatilho:** médico inicia gravação visível ou envia áudio autorizado.

Fluxo principal

1. O sistema verifica o consentimento.
2. O médico inicia conscientemente a captura ou envia arquivo.
3. O serviço transcreve.
4. Trechos de baixa confiança são destacados.
5. O médico revisa a transcrição.
6. A transcrição validada pode alimentar o UC-06.
7. O áudio é retido ou excluído conforme política aprovada.

Critérios de aceitação essenciais

- Não existe gravação automática ou oculta.
- Sem consentimento, o médico usa notas manuais.

- O paciente percebe claramente quando há gravação.
- Áudio, transcrição e nota possuem vínculo e regras de acesso.
- Falha de transcrição não bloqueia o atendimento.

UC-14 — Trocar mensagens dentro do Vivance

- **Prioridade:** P1.
- **Atores:** paciente, médico, sistema e copiloto de IA.
- **Objetivo:** centralizar comunicação assíncrona com expectativa clara de resposta.
- **Pré-condições:** política operacional e prazo de resposta definidos.
- **Gatilho:** paciente ou médico inicia uma conversa.

Fluxo principal

1. O usuário envia a mensagem.
2. O sistema registra entrega e leitura.
3. O médico consulta o contexto.
4. A IA pode sugerir um rascunho.
5. O médico edita e envia.
6. A conversa é vinculada à linha do tempo.

Critérios de aceitação essenciais

- A tela informa que não é canal de emergência.
- A IA nunca responde diretamente.
- Notificações externas não mostram conteúdo clínico.
- Falhas podem ser reenviadas sem duplicação.
- Conta ou vínculo revogado impede novas mensagens.

14. Regras iniciais para a fila de atenção

O MVP-2 deve começar somente com regras operacionais determinísticas. Parâmetros e textos precisam ser aprovados pelo Dr. Guilherme.

Possíveis regras:

- Pré-consulta não concluída antes da consulta.
- Pré-consulta enviada e ainda não revisada.
- Check-in atrasado por período configurado.
- Nota ou plano aguardando revisão.

- Documento aguardando validação, quando o módulo P1 existir.
- Próxima revisão vencida.

Cada regra precisa definir:

- Nome e objetivo.
- Dado de origem.
- Condição exata.
- Prioridade organizacional.
- Quem revisa.
- Prazo operacional.
- Ação esperada.
- Critério de encerramento.
- Comportamento em duplicidade.

O termo “atenção” não equivale a diagnóstico, triagem, emergência ou risco clínico confirmado. Regras que interpretem sintomas, piora ou risco exigem avaliação preliminar de risco, validação clínica, governança e cobertura operacional antes de serem consideradas.

15. Modelo de dados mínimo

Os nomes abaixo são conceituais; adaptar ao padrão do repositório.

Identidade e organização

- Organization.
- UserAccount.
- Membership.
- Role.
- DoctorProfile.
- PatientProfile.
- DoctorPatientLink.
- ExternalReference.

Mesmo com uma única clínica no piloto, registros clínicos devem possuir um identificador de organização. O tenant deve ser derivado da sessão autenticada, nunca aceito livremente do cliente.

Privacidade

- PrivacyNoticeVersion.

- ConsentRecord.
- DataProcessingPurpose.
- DataSubjectRequest.
- RetentionPolicy.
- LegalHold, se aplicável.

Consentimentos diferentes não devem ser comprimidos em um único booleano.

Cuidado longitudinal

- Encounter.
- PreConsultation.
- Questionnaire.
- QuestionnaireResponse.
- Observation.
- CheckIn.
- CarePlan.
- CarePlanAction.
- ClinicalNote.
- Document.
- MediaAsset.
- AttentionRule.
- AttentionItem.
- DoctorAction.
- TimelineEvent.

Cada observação deve registrar, quando aplicável:

- Organização e paciente.
- Origem e autoria.
- Momento observado e momento registrado.
- Valor, unidade e método.
- Status de validação.
- Correção ou versão anterior.

IA e revisão humana

- AIUseCase.
- AIExecution.

- AIArtifact.
- ReviewDecision.
- PromptTemplateVersion.
- ModelProviderVersion.

Registrar, no mínimo:

- Finalidade.
- Caso de uso e classificação preliminar de risco.
- Serviço e versão do modelo.
- Versão do prompt/template.
- Referências das entradas.
- Horário.
- Status do artefato.
- Revisor.
- Decisão de aprovação/rejeição.
- Motivo de rejeição ou edição relevante.

Evitar duplicar dados pessoais dentro do registro técnico da execução. Quando possível, guardar referências protegidas às fontes em vez de copiar todo o conteúdo clínico para logs.

Integrações e auditoria

- IntegrationConnection.
- SyncJob.
- SyncAttempt.
- FeegowReference.
- AuditEvent.
- SecurityIncident.

A auditoria registra ator, ação, organização, recurso, data, resultado e origem sem copiar desnecessariamente o conteúdo clínico.

16. Arquitetura recomendada para o MVP

Direção

Começar com um **monólito modular**, com fronteiras claras, evitando microserviços prematuros.

Componentes recomendados:

- Frontend web responsivo.
- API privada.
- Banco PostgreSQL.
- Armazenamento privado de objetos.
- Fila e worker para IA, transcrição e geração de documentos.
- Gateway próprio para provedores de IA.
- Camada de integrações.
- Auditoria e observabilidade.

Módulos sugeridos:

1. Identidade e acesso.
2. Organizações, vínculos e permissões.
3. Pacientes e consentimentos.
4. Pré-consulta.
5. Consultas e notas auxiliares.
6. Planos e acompanhamento.
7. Arquivos e documentos.
8. IA e revisão humana.
9. Integrações.
10. Auditoria e privacidade.

Compatibilidade com o protótipo

React/Next.js/TypeScript/Tailwind podem ser preservados caso o repositório real confirme essa arquitetura. Antes de implementar backend ou persistência:

- Confirmar se o projeto usa Next.js diretamente ou Vinext/Vite.
- Identificar componentes puramente demonstrativos.
- Remover dependência de estado apenas em memória.
- Criar contratos de domínio antes de ligar telas a dados reais.
- Preservar a experiência mobile-first do paciente e desktop-first do médico.

Regras técnicas obrigatórias

- Autorização validada no servidor em toda leitura e mutação.
- Segredos e tokens fora do frontend e do repositório.
- Chamadas de IA realizadas pelo backend.
- Dados clínicos não armazenados persistentemente em localStorage.

- Páginas autenticadas com dados sensíveis sem cache público.
- Buckets privados e URLs temporárias para arquivos.
- Validação de tipo real, tamanho, malware e conteúdo inesperado em uploads.
- Criptografia em trânsito e em repouso, inclusive em backups.
- Separação entre produção, staging e desenvolvimento.
- MFA para médico e administradores.
- Proibição de contas compartilhadas.
- Logs técnicos sem conteúdo clínico.
- Backup criptografado e restauração testada.
- Feature flag e desligamento rápido para cada caso de uso de IA.
- Rate limiting, proteção contra abuso e expiração de sessão.
- UUIDs internos; e-mail, telefone e CPF não são chaves primárias.
- Testes automáticos de isolamento entre pacientes e organizações.

Multi-clínica

A interface e a operação multi-clínica ficam fora do MVP. Entretanto, a estrutura deve evitar mistura de dados desde o início:

1. Identificador de organização em todos os registros relevantes.
2. Autorização na aplicação.
3. Isolamento no banco, como Row-Level Security ou mecanismo equivalente.
4. Testes que tentem enumerar, consultar, alterar e baixar dados de outra organização.

Não criar um prontuário global compartilhado entre clínicas.

17. Princípios de integração

Feegow

- Confirmar oficialmente a API, permissões e limites.
- Mapear identificadores externos.
- Começar com cópia/exportação controlada.
- Implementar idempotência antes de qualquer escrita automática.
- Nunca sobrescrever registro assinado silenciosamente.
- Exibir status e data da transferência.
- Manter fila de erros e correção manual.
- Registrar quem aprovou o conteúdo.

- Inspecionar e testar o agente_vivance.py antes de reutilizá-lo.

Provedores de IA e transcrição

- Usar conta/API corporativa aprovada, nunca conta pessoal para dados reais.
- Confirmar que dados não serão usados para treinamento.
- Definir retenção, subprocessadores e transferências internacionais.
- Enviar somente os dados necessários.
- Usar identificador interno quando o nome não for necessário.
- Fixar e registrar versão do modelo.
- Validar saídas por schema estruturado.
- Tratar PDFs, mensagens e transcrições como entradas não confiáveis e proteger contra prompt injection.
- Não permitir troca silenciosa de modelo em produção.
- Manter o produto independente de Claude, GPT ou de uma versão específica.

WhatsApp

No MVP-1, o contato pode continuar externo e ser apenas registrado como ação do médico.

Se integrado futuramente:

- Usar fornecedor autorizado.
- Registrar preferência de canal e opt-out.
- Evitar detalhes clínicos desnecessários.
- Exigir aprovação antes de conteúdo clínico.
- Não comunicar diagnóstico, prognóstico ou tratamento por IA autônoma.

Google Drive

- Não usar pastas pessoais ou links públicos para dados clínicos.
- Uma integração futura exige conta corporativa, permissão mínima, auditoria e contrato adequado.
- O armazenamento clínico principal deve permanecer privado e controlado.

PULSE, Visus Vector, wearables e bases científicas

Permanecem pós-MVP até que:

- O fluxo principal esteja validado.
- A fonte oficial de cada dado esteja definida.

- Haja documentação técnica e autorização.
- O ganho clínico justifique a superfície adicional de risco.

18. Segurança clínica, LGPD e governança

Esta seção orienta produto e engenharia; não substitui revisão médica, jurídica, de privacidade ou regulatória.

18.1 Gate antes de qualquer dado real

Enquanto os itens abaixo não estiverem concluídos, todos os ambientes devem usar exclusivamente dados fictícios ou sintéticos.

- ☐ Papel do Vivance e fonte oficial do prontuário confirmados.
- ☐ Público, duração e critérios do piloto definidos.
- ☐ Responsável médico e responsáveis por produto, privacidade e segurança definidos.
- ☐ Inventário de dados, finalidades e bases legais concluído.
- ☐ Controlador, operadores e suboperadores definidos.
- ☐ Aviso de privacidade e fluxo de direitos dos titulares aprovados.
- ☐ Ciência do aviso, termos, bases legais e consentimentos aplicáveis definidos e versionados separadamente.
- ☐ Fluxo integralmente manual definido para a recusa do uso de IA ligado ao cuidado ou da gravação.
- ☐ Avaliação preliminar de risco de cada caso de uso de IA documentada.
- ☐ Autenticação, autorização, criptografia, auditoria e backups implementados.
- ☐ Retenção e exclusão definidas por categoria de dado.
- ☐ Fornecedores avaliados quanto a segurança, treinamento, retenção e transferência internacional.
- ☐ Plano de resposta a incidentes aprovado.
- ☐ Horários, expectativa de resposta e escalonamento operacional definidos.
- ☐ Testes de isolamento, backup/restauração, falhas de IA e integrações concluídos.
- ☐ Aprovação formal clínica, técnica e de privacidade para iniciar o piloto.

Recomenda-se um Relatório de Impacto à Proteção de Dados ou avaliação equivalente antes do piloto, sujeito à orientação jurídica aplicável.

18.2 Requisitos atuais para IA na medicina

A Resolução CFM nº 2.454/2026 está vigente desde 26 de agosto de 2026. Para este produto, os principais efeitos práticos são:

- A IA é ferramenta de apoio; o médico mantém responsabilidade e decisão final.
- O uso de IA como apoio à decisão deve ser registrado no prontuário.
- Qualquer utilização de IA deve ser comunicada e explicada ao paciente; quando o apoio influenciar o cuidado, a explicação precisa ser especialmente clara e rastreável.
- A recusa informada do paciente deve ser respeitada.
- A comunicação de diagnóstico, prognóstico ou decisão terapêutica não pode ser delegada à IA.
- A instituição deve realizar avaliação preliminar e classificar o risco antes do uso, informando essa classificação ao usuário conforme aplicável.
- Supervisão humana, auditoria, monitoramento, segurança e privacidade são obrigatórios.

Antes do piloto, obter avaliação jurídica sobre a aplicação ao Instituto Vivance da Comissão de IA e Telemedicina prevista no art. 14, parágrafo único, para instituições que desenvolvam sistemas próprios de IA.

Fonte oficial: [Resolução CFM nº 2.454/2026](#).

18.3 Privacidade por padrão

Dados de saúde são dados pessoais sensíveis. Aplicar minimização desde banco, arquivos e prompts até logs e analytics.

Regras mínimas:

- Não tratar consentimento como autorização genérica.
- Definir finalidade e base legal para cada operação.
- Não confundir ciência do aviso de privacidade com consentimento.
- Coletar somente o necessário.
- Não usar dados reais em desenvolvimento, staging, demo ou teste.
- Não enviar dados de pacientes para contas pessoais ou ferramentas públicas de IA.
- Não incluir dados clínicos em URLs, nomes públicos de arquivos, telemetria ou logs de erro.
- Não instalar pixels de marketing ou trackers de terceiros em áreas autenticadas.
- Não colocar conteúdo clínico em push, SMS ou e-mail.
- Criar processo para acesso, correção, informação, revogação e exclusão.
- Avaliar transferência internacional de dados.
- Manter canal de privacidade e responsabilidades definidas.

Fonte oficial: [Lei Geral de Proteção de Dados — Lei nº 13.709/2018](#).

18.4 Retenção

Criar uma matriz separada para:

- Registro clínico final.
- Pré-consulta e check-ins.
- Documentos originais.
- Áudio.
- Transcrição.
- Rascunhos aprovados e rejeitados.
- Mensagens.
- Logs de auditoria.
- Logs técnicos.
- Backups.

Se um artefato fizer parte do prontuário, não deve ser apagado automaticamente em resposta a uma solicitação genérica. A Lei nº 13.787/2018 exige integridade, autenticidade e confidencialidade e prevê, para prontuários, prazo mínimo de 20 anos a partir do último registro antes de eventual eliminação, ressalvadas regras específicas.

Fonte oficial: [Lei nº 13.787/2018](#).

Para áudio de consulta, utilizar o menor prazo necessário e excluir após validação da transcrição e da nota, salvo justificativa clínica e jurídica expressa.

18.5 Incidentes

O plano deve incluir:

- Classificação e contenção.
- Preservação de evidências.
- Responsáveis e comunicação interna.
- Avaliação do risco aos titulares.
- Comunicação à ANPD e aos titulares quando exigida.
- Revisão posterior e medidas corretivas.

Quando o incidente puder causar risco ou dano relevante, a Resolução CD/ANPD nº 15/2024 estabelece comunicação pelo controlador à ANPD e aos titulares em três dias úteis, ressalvada legislação específica.

Fonte oficial: [Comunicação de Incidente de Segurança — ANPD](#).

18.6 Segurança do paciente

- Informar que o aplicativo não é serviço de emergência.
- Informar que mensagens e check-ins podem não ser vistos imediatamente.
- Exibir o canal correto para urgências.
- Não prometer monitoramento contínuo.
- Não usar “seguro”, “sem risco” ou equivalentes com base apenas na IA.
- Validar questionários e regras clinicamente antes da ativação.
- Publicar conteúdo clínico somente após aprovação médica.
- Permitir desligar rapidamente um caso de uso de IA.

18.7 Possível enquadramento regulatório

Antes de introduzir diagnóstico, predição clínica, triagem, score de risco ou recomendação terapêutica, realizar avaliação específica sobre Software as a Medical Device. Esses recursos ficam fora do MVP.

Fonte oficial: [Anvisa — RDC nº 657/2022 e Software como Dispositivo Médico](#).

19. Requisitos não funcionais

Segurança e privacidade

- Controle de acesso com menor privilégio.
- MFA para perfis privilegiados.
- Criptografia em trânsito e repouso.
- Auditoria de ações sensíveis.
- Segregação de ambientes.
- Varredura de dependências e segredos.
- Testes contra acesso horizontal entre pacientes.

Confiabilidade

- Fluxo manual quando IA ou integração falhar.
- Operações idempotentes.
- Reprocessamento seguro de jobs.
- Backups com restauração testada.
- Estados de erro compreensíveis.

- Nenhuma indicação falsa de envio ou sincronização.

Desempenho

- Interfaces principais utilizáveis em rede móvel comum.
- Check-in e pré-consulta com salvamento progressivo.
- Jobs demorados executados de forma assíncrona.
- Feedback claro de processamento, falha e nova tentativa.

Acessibilidade e UX

- Navegação por teclado na experiência médica.
- Contraste e tamanho de toque adequados no mobile.
- Linguagem simples para pacientes.
- Estados da IA e da aprovação claramente diferenciados.
- Sem dark patterns nos consentimentos.

Observabilidade

- Logs técnicos sem conteúdo clínico.
- Métricas de erro e latência.
- Monitoramento de jobs e integrações.
- Alertas de segurança.
- Métricas de qualidade das saídas da IA.

Testabilidade

- Testes unitários de regras e permissões.
- Testes de integração do banco e jobs.
- Testes de contrato para provedores externos.
- Testes E2E das jornadas incluídas em cada entrega.
- Testes com entradas maliciosas, arquivos inválidos e prompt injection.
- Casos de regressão para alucinação, omissão e inclusão indevida de medicamentos.

20. Métricas do piloto

Eficiência médica

- Tempo de preparação para consulta.
- Tempo para finalizar a nota.
- Tempo entre consulta e publicação do plano.
- Quantidade de edição necessária no rascunho.
- Percentual de rascunhos aprovados, rejeitados ou refeitos.
- Tipos de correção do médico.

Experiência do paciente

- Pré-consultas iniciadas e concluídas.
- Tempo e abandono por etapa.
- Pacientes que acessaram o plano.
- Adesão aos check-ins.
- Percepção de clareza do plano.

Qualidade operacional

- Itens de atenção gerados.
- Percentual considerado relevante.
- Falsos positivos.
- Tempo até revisão.
- Falhas de exportação.
- Erros de permissão ou privacidade.

Segurança da IA

- Informações inventadas.
- Omissões relevantes.
- Diagnóstico ou medicamento inserido sem fonte.
- Conteúdo publicado sem aprovação.
- Divergência entre fonte, rascunho e versão aprovada.
- Uso de IA sem o registro ou a transparência exigidos.

Não declarar sucesso apenas por resultado clínico como perda de peso. O piloto deve primeiro validar segurança, utilidade, adesão e redução de trabalho.

Metas numéricas devem ser definidas depois de medir uma linha de base real.

21. Ordem recomendada de implementação

Etapa 0 — Decisões e gate de segurança

- Confirmar fronteira com Feegow.
- Confirmar o MVP-1 e o momento de iniciar o MVP-2.
- Aprovar questionário e plano; check-in e regras de atenção podem ser aprovados antes do MVP-2.
- Definir bases legais, avisos, consentimentos aplicáveis, privacidade, retenção e fornecedores.
- Confirmar responsáveis e critérios de interrupção do piloto.

Etapa 1 — Fundação

- Autenticação.
- Organização e vínculo médico-paciente.
- Avisos, termos, bases legais e consentimentos aplicáveis.
- Banco persistente.
- Autorização no backend.
- Auditoria.
- Estrutura de IA e revisão.

Etapa 2 — Preparação da consulta

- Cadastro mínimo.
- Pré-consulta por texto.
- Dossiê.
- Síntese com fontes.
- Painel de pendências.

Etapa 3 — Consulta e documentação

- Workspace.
- Notas ou transcrição colada.
- Rascunho estruturado.
- Revisão e aprovação.

- Exportação e confirmação de transferência ao Feegow.
- Plano de cuidado e publicação ao paciente.

Etapa 4 — Hardening e piloto do MVP-1

- Testes completos das jornadas A e B.
- Revisão de segurança, privacidade e clínica.
- Treinamento do médico.
- Piloto pequeno e controlado.
- Coleta de métricas, correções e incidentes.

Etapa 5 — MVP-2: acompanhamento longitudinal

- Check-in.
- Linha do tempo.
- Regras operacionais e fila de atenção.
- Registro da ação médica.
- Nova revisão do gate e piloto da jornada C.

Etapa 6 — Uma extensão P1

Escolher apenas uma:

- Transcrição nativa.
- Relatório de calorimetria ou bioimpedância.
- Integração Feegow.
- Mensagens internas.

A escolha deve responder ao maior gargalo observado no piloto.

22. Definition of Done

MVP-1 pronto para piloto

- ☐ O médico autentica com MFA, verifica o paciente, cria o vínculo e controla o convite.
- ☐ Um paciente é convidado, autentica, registra ciência/aceites aplicáveis e completa a pré-consulta sem suporte técnico.
- ☐ O médico vê respostas originais e síntese rastreável.
- ☐ O médico cria, revisa e aprova uma nota.

- ☐ A IA nunca publica ou aprova por conta própria.
- ☐ A nota aprovada pode ser transferida de forma segura ao Feegow.
- ☐ O médico cria e publica um plano.
- ☐ O paciente acessa o plano aprovado.
- ☐ Todas as ações sensíveis ficam auditadas.
- ☐ Um paciente não acessa dados de outro paciente.
- ☐ Um usuário de outra organização não acessa dados do Instituto.
- ☐ Existem backup, restauração, revogação e processo de direitos do titular.
- ☐ O fluxo principal funciona quando a IA está indisponível.
- ☐ Dados originais, inferência da IA e conteúdo aprovado são distinguíveis.
- ☐ Bases legais, avisos, consentimentos aplicáveis, transparência e registro do uso de IA estão implementados.
- ☐ Testes com dados fictícios foram concluídos antes de qualquer dado real.
- ☐ O gate clínico, técnico, jurídico e de privacidade foi aprovado.

MVP-2 pronto para piloto

Além dos critérios do MVP-1:

- ☐ O paciente responde ao check-in e vê seu histórico sem dados inferidos.
- ☐ Uma regra operacional aprovada cria um item de atenção explicável.
- ☐ O médico registra uma ação e encerra o item.
- ☐ Não há interpretação automática de sintomas ou urgência.
- ☐ A relevância e os falsos positivos das regras podem ser medidos.
- ☐ O novo escopo passou por avaliação de risco e nova aprovação do gate.

23. Decisões pendentes para validar com o Dr. Guilherme

Produto e piloto

1. O problema prioritário é preparação/documentação médica, acompanhamento do paciente ou ambos?
2. A ordem recomendada — MVP-1 de eficiência e depois MVP-2 longitudinal — está correta?
3. O piloto será somente com adultos?
4. Quantos pacientes participarão e por quanto tempo?

5. Quais critérios interrompem o piloto?

Fluxo clínico

6. Quais perguntas entram na primeira pré-consulta?
7. Quais campos formam a nota a ser levada ao Feegow?
8. Qual é o primeiro template de plano?
9. Qual é a frequência e o conteúdo do check-in?
10. Quais regras criam um item de atenção?
11. Qual prazo de resposta será comunicado ao paciente?
12. Qual orientação permanente e quais canais devem ser mostrados para urgência/emergência?

Sistemas e integrações

13. O Feegow continuará como prontuário oficial?
14. A agenda oficial permanece apenas no Feegow?
15. A transferência inicial será cópia, arquivo ou API?
16. O agente_vivance.py existe, onde roda e o que realmente lê/escreve?
17. Feegow, PULSE, Visus e Drive possuem APIs e autorizações disponíveis?
18. Qual canal será oficial para comunicação no piloto?

Dados, IA e segurança

19. Quais dados podem ser enviados a cada fornecedor de IA?
20. Qual fornecedor poderá processar dados sensíveis?
21. Qual retenção será aplicada a áudio, transcrição, documentos, rascunhos e logs?
22. Quem será controlador, operador e responsável por privacidade?
23. Como o uso de IA será informado e registrado no prontuário?
24. Quem aprova a avaliação preliminar de risco dos casos de uso?
25. O Vivance precisará da Comissão de IA e Telemedicina prevista na Resolução CFM nº 2.454/2026?

Identidade e marca

26. Qual é o nome oficial da marca e o domínio de produção?
27. Quais são CRM, UF e RQE corretos do Dr. Guilherme?
28. O endereço profissional em Presidente Prudente está correto para documentos?

24. O que o Codex não deve inferir

- Que todos os itens dos MDs são requisitos aprovados.
- Que toda tela do protótipo pertence ao MVP.
- Que uma funcionalidade visual possui backend.
- Que o agente_vivance.py existe ou funciona.
- Que Feegow, WhatsApp, PULSE, Visus ou Drive possuem integração disponível.
- Que wa.me significa integração com WhatsApp.
- Que números fictícios representam volume real.
- Que PDFs mockados são templates clínicos aprovados.
- Que a IA pode “estruturar conduta” criando uma conduta.
- Que revisão humana, sozinha, resolve LGPD e segurança.
- Que dados não persistidos na memória de uma IA não são processados ou retidos por fornecedores.
- Que o paciente autoriza qualquer uso de IA ao aceitar um termo genérico.
- Que alertas equivalem a risco clínico ou emergência.
- Que mensagens podem ser enviadas automaticamente.
- Que o produto será multi-clínica, 24/7, multilíngue ou integrado a wearables no MVP.
- Que um modelo específico de Claude ou GPT é requisito arquitetural.
- Que informações profissionais, URL, commit ou stack registrados em agosto continuam corretos.
- Que dados clínicos podem ser usados para treinamento.
- Que o Vivance pode substituir o prontuário oficial sem nova avaliação.

25. Resumo executivo para implementação

O MVP recomendado não tenta construir um prontuário completo nem reproduzir todos os usos de ChatGPT e Claude do Dr. Guilherme.

O MVP-1 entrega um ciclo seguro:

1. Médico verifica o paciente e envia o convite.
2. Paciente entra, recebe as informações obrigatórias e manifesta os aceites aplicáveis.
3. Paciente prepara a consulta.
4. Médico recebe contexto rastreável.
5. IA organiza um rascunho.
6. Médico decide, edita e aprova.
7. Nota segue para o prontuário oficial.

8. Plano aprovado chega ao paciente.

O MVP-2 adiciona:

1. Check-ins simples.
2. Pendências operacionais transparentes.
3. Registro da ação médica.
4. Novo contexto longitudinal para o próximo ciclo.

Se o MVP-1 for seguro, útil e mensuravelmente melhor que o processo atual, o produto terá base para validar o acompanhamento longitudinal e depois adicionar transcrição, exames, mensagens e integrações sem inflar prematuramente o risco e o escopo.